

Publicité

 Recherche pour:

- [Cardiologie](#)
- [Dermatologie](#)
- [Douleur](#)
- [Endocrinologie](#)
- [Gynécologie](#)
- [Handicap](#)
- [Hématologie](#)
- [Hépto-gastro](#)
- [Immunologie](#)
- [LCA](#)
- [Maladies infectieuses](#)
- [Méthodologie](#)
- [Néphrologie](#)
- [Neurologie](#)
- [Oncologie](#)
- [Ophtalmologie](#)
- [ORL](#)
- [Orthopédie](#)
- [Pédiatrie](#)
- [Pneumologie](#)
- [Pratique médicale](#)
- [Psychiatrie](#)
- [Réanimation](#)
- [Rhumatologie](#)
- [Thérapeutique](#)
- [Urologie](#)

[S'Identifier](#)

- [Home](#)
- [Fiche prepECN](#)
- [Ma Fiche](#)
- [Consensus](#)
- [Imagerie](#)
- [Discussion](#)

Item 292: Algies pelviennes chez la femme

16 décembre, 2010

Objectifs CNCI

- Devant des algies pelviennes chez la femme, argumenter les principales hypothèses diagnostiques et justifier les examens complémentaires pertinents

Recommandations	Mots-clés / Tiroirs	NPO / PMZ
- Poly national: item 292	- Digestif: appendicite / urologique: CN - Test de grossesse positif: GEU-ASP - Nécrobiose / IUA / torsion / rupture - Cyclique / MTR / TR / BU / défense - Endométriose: dysménorrhées / IRM: hyperS T2 / progestatifs ou agonistes LHRH / coelioscopie	- DDR / hCG / contraception - Prise de la température - Bilan IST si salpingite

- Etiologies

- Douleur pelvienne aiguë
 - Causes gynécologiques
 - Etiologies obstétriques: grossesse extra-utérine +++ / avortement spontané
 - Etiologies endo-utérines: fibrome (nécrobiose) / endométriose / endométrite
 - Etiologies annexielles: torsion d'annexe +++ / rupture de kyste / salpingite
 - Causes non gynécologiques
 - Etiologies digestives: appendicite ++ / diverticulite
 - Etiologies urologiques: colique néphrétique ++ / pyélonéphrite-cystite
- Douleur pelvienne chronique
 - Causes gynécologiques

- Etiologies endo-utérines
 - Cancer du col / cancer de l'endomètre / fibromes
 - Endométriose / adénomyose / prolapsus
- Etiologies annexielles: cancer de l'ovaire
- Causes non gynécologiques
 - Etiologies digestives: constipation chronique
 -

- Orientation diagnostique

- Examen clinique
 - Interrogatoire
 - Terrain: atcd gynéco-obstétriques (salpingite / GEU) / médicaux
 - Prises: contraception (DIU) / aspirine-AVK / tabac
 - Anamnèse: **DDR** / aiguë ou chronique / facteur déclenchant
 - Signes fonctionnels
 - Caractériser la douleur pelvienne
 - Localisation / irradiation / intensité / caractère **cyclique** ++
 - Rechercher des signes associés
 - **Métrorragies** ou leucorrhées (aspect, abondance..) / fièvre / AEG
 - Signes urinaires ou digestifs / signes chez le partenaire (cf IST)
 - Examen physique
 - Prise des constantes: **température** / PA-FC / FR-SpO2 / diurèse
 - Examen gynécologique
 - Palpation abdominale: douleur / **défense** / masse
 - Inspection vulvaire: recherche leucorrhée / inflammation
 - Examen au spéculum: recherche saignement (localisation) / aspect du col
 - Toucher vaginal: douleur à la mobilisation utérine / masse annexielle
 - Examen des seins: signes sympathiques de grossesse / écoulement / nodule
 - Examen général
 - Examen abdominal: douleur à la palpation / **TR**: cul-de-sac de Douglas
 - Examen urologique: bandelette urinaire (**BU**) / palpation fosses lombaires
- Examens complémentaires
 - Examens en 1ère intention (PMZ)
 - hCG plasmatiques quantitatifs: recherche une grossesse / test **urinaire** en ville
 - Echographie pelvienne: signes de GEU / de salpingite / de pathologie annexielle, etc.
 - Examens selon le contexte clinique
 - Si patiente fébrile : **NFS-CRP-PV-ECBU** / hémocultures / bilan IST
 - Si hémorragie génitale: NFS-P / hémostase: TP-TCA

- Diagnostic étiologique

- Algies pelviennes aiguës
 - Grossesse extra-utérine (GEU) +++ (cf [item 18](#))
 - Toute douleur pelvienne est une GEU jusqu'à preuve du contraire +++
 - Examen clinique = triade: métrorragie / douleur pelvienne / retard de règles
 - Examens complémentaires
 - hCG quantitatifs: augmentés avec cinétique anormale
 - Echographie pelvienne: signes directs (2) et indirects (5)

- Avortement spontané précoce (ASP = FCS) (cf [item 17](#))
 - Examen clinique = grossesse en T1 (DDR) / métrorragies / crampes pelviennes
 - Examens complémentaires
 - hCG plasmatiques: décroissance brutale du taux en 48h (≠ GEU)
 - Echographie pelvienne: pas d'activité cardiaque / sac hyptonique
- Salpingite aiguë (infection utéro-annexielle) (cf [item 88](#))
 - Prise de la température devant toute douleur pelvienne +++ (PMZ)
 - Examen clinique
 - douleur pelvienne / leucorrhée purulente / métrorragie / partenaire
 - TV = douleur à la mobilisation utérine / TR = irritation péritonéale
 - Examens complémentaires
 - Bilan infectieux: NFS-CRP / plts locaux / hémocultures / ECBU
 - Bilan IST si salpingite confirmée +++ (PMZ) / NPO partenaire !
- Fibromes utérins (cf [item 147](#))
 - Nécrobiose aseptique: fièvre / fibrome mou / « cocarde » à l'échographie
 - Torsion: sur fibrome sous-séreux pédiculé (rare)
- Pathologie annexielle (cf [item 153](#))
 - Torsion d'annexe sur kyste +++
 - Examen clinique: douleur pelvienne brutale intense / latéralisés / défense
 - Ex. complémentaires: hCG négatifs et échographie = kyste volumineux +++
 - Rupture hémorragique d'un kyste de l'ovaire
 - Examen clinique: douleur brutale et irritation péritonéale +/- hémopéritoine
 - Ex. complémentaires = hCG négatifs (≠ GEU) / écho = lame dans Douglas
 - Hémorragie intra-kystique
 - Douleur brutale latéralisée +/- masse latéro-utérine douloureuse au TV
 - Diagnostic à l'écho: visualisation du saignement intra-kystique
- Algies pelviennes chroniques (> 6M)
 - Endométriose +++
 - Définition
 - = foyers ectopiques extra-utérins de tissu endométrial (endométrïomes)
 - Atteinte plurifocale: sur péritoine / ovaires / petit-bassin / rectum, etc.
 - Examen clinique
 - Terrain: femme jeune / souvent nullipare ou infertile
 - Douleur pelviennes **cycliques**: dysménorrhées secondaires tardives
 - Orientation topographique:
 - atteinte sous-péritonéale: dyspareunies profondes
 - atteinte digestive: rectorragies / ténesme / épreintes
 - atteinte urinaire: hématurie / impériosités mictionnelles
 - Examens complémentaires
 - Echographie: endométrïome ovarien ~ kyste (!! et CA 125 ↑)
 - IRM pelvienne: ex. de **référence**: greffes endométriales en hyperT2
 - Coelioscopie: seulement si geste thérapeutique associé désormais
 - Traitement
 - Médicamenteux: macroprogestatifs + agonistes LHRH pendant 3M
 - Chirurgical: si échec: coelioscopie pour coagulation +/- exérèse
 - Adénomyose
 - Définition
 - = foyers de tissus endométrial dans le *myomètre*
 - « endométrïose de localisation myométriale »
 - Examen clinique
 - Femme en péri-ménopause; multipares ++ / utérus dur et douloureux

- Dysménorrhée secondaires et tardive / ménorragies / dyspareunie
- Examen complémentaires
 - IRM pelvienne +++ : foyers endométriaux intra-myomètre en hyperT2
 - Hystérocopie: orifices de pénétration intra-myométriale bleutées
 - Hystérographie: images « diverticulaires » (obsolète en pratique)
- Traitement
 - Médicamenteux = progestatifs + agonistes LHRH pendant 3-6M
 - Chirurgical = hystérectomie totale si patiente d'âge mûr (++)
- Salpingite chronique
 - Tableau à bas bruit / pas de fièvre / sur IST à chlamydia +++
 - Diagnostic par PCR et coelioscopie: bilan lésionnel +/- Tt (adhérences ++)
- Autres étiologies
 - Rétroversion utérine = malposition utérine banale: pesanteur / dyspareunie
 - Congestion pelvienne = troubles de la circulation veineuse (pas de valvules)
 - Sd de Masters et Allen = déchirure du ligament large / mobilité anormale de l'utérus
 - Non gynécologiques = digestives (rectum, intestin) / uro (vessie) / ostéo, etc.
 - Psychogènes = troubles somatoformes (cf [item 289](#)) / !! diagnostic d'élimination
- Algies pelviennes cycliques
 - Dysménorrhée (= algoménorrhée)
 - = douleurs pelviennes contemporaines des règles (« règles douloureuses »)
 - !! extrêmement fréquent: > 50% des femmes dont 10% de cas handicapant
 - Etiologies
 - dysménorrhées primaire (« essentielles »: multifactorielles: contraction, PG, psy..)
 - dysménorrhées secondaires (organiques: endométriose ++ / sténose du col..)
 - Traitement
 - si essentielle: AINS / oestro-progestatifs / anti-prostaglandines (Ponstyl®)
 - si organique: celui de la cause
 - Syndrome inter-menstruel = douleur ovulatoire
 - Physiopath: ovulation = rupture folliculaire: libération d'oestrogènes → métrorragies
 - Clinique: douleur en milieu de cycle (cf ovulation) avec métrorragies minimales
 - Paraclinique: hCG négatifs et échographie normale ou lame dans Douglas
 - Syndrome pré-menstruel
 - = symptômes précédant l'apparition des règles / disparaissent après quelques jours
 - Physiopath: insuffisance lutéale (involution précoce CJ) → hyperoestrogénie relative
 - Clinique: tension mammaire / douleur abdomino-pelvienne / troubles de l'humeur, etc.
 - Traitement: progestatifs en seconde partie de cycle: J15 – J25 (idem péri-ménopause)

[A propos](#) - [Conditions Générales de Ventes](#) - [Informations Légales](#) - [F.A.Q](#) - [Nous contacter](#)

Copyright © 2011 prepECN, all rights reserved - Powered by [Allworldregister.info](http://www.allworldregister.info)

chargement